이주민 건강을 함께 지원하는 교회·지역단체 안내문

[핵심 요약]

본 안내문은 이주민 및 영유아 건강권 실태조사와 관련 정책 연구를 바탕으로 작성되었습니다. 자료에 따르면 이주민은 언어 장벽, 제도적 배제, 열악한 노동 및 주거 환경으로 인해 보건의료 접근성이 매우 낮습니다. 교회와 지역단체는 이러한 이주민이 의료 사각지대에 방치되지 않도록 공공 보건의료 체계 및 보건소로 연계하는 지역사회의 다리 역할을 수행해야 합니다.

1. 자료로 확인된 이주민 건강 취약 요인

- **언어 장벽:** 보건의료 정보에 대한 접근성을 낮추고 의료기관 이용 시 정확한 증상 설명을 어렵게 합니다.
- **사회적 배제 및 차별:** 의료기관 및 지역사회 내 차별 경험이 의료 서비스 이용을 기피하게 만듭니다.
- **주거 및 노동환경:** 밀집된 기숙사 생활, 고위험 노동 환경 등이 감염병 전파 및 산업재해 위험을 높입니다.
- **건강보험 배제 및 제한:** 제도적 기준(체류 자격, 기간 등)으로 인해 건강보험에 가입하지 못하는 경우가 다수 존재합니다.
- **장기체류에 따른 건강 악화:** 입국 초기 건강했던 이주민이 고된 노동과 스트레스 누적으로 인해 점차 건강이 악화되는 현상(건강한 이주민 효과 저하)이 나타납니다.

2. 체류자격(비자)별 주요 건강 이슈 및 유의점

대상군 (비자)	자료에서 확인된 주요 건강 이슈	교회·지역단체가 유의할 점
외국인 노동자 (E-9, E-10, H-2)	산업재해, 직업병, 기숙사 단체생활로 인한 감염병 위험 노출	산재 위험 요인 인지 시 관련 지정 의료기관 및 이주민지원센터 연계
전문인력 (E-1 ~ E-7)	고강도 직무 스트레스, 동반가족의 한국 의료체계 적응의 어려움	가족 단위의 건강검진 및 보건소 예방접종 일정 안내

대상군 (비자)	자료에서 확인된 주요 건강 이슈	교회·지역단체가 유의할 점
동반가족 (F-3)	보건의료 정보 접근성 제한, 아동 필수 예방접종 누락	영유아 모자보건 서비스 및 학교 보건 체계와의 연결 지원
결혼이민 (F-6)	임신·출산 합병증, 산후 우울증, 양육 스트레스	보건소 산전후 관리 프로그램 안내 및 위기 상황 시 상담 연계
정주 이주민 (F-2, F-4, F-5)	체류 장기화 및 고령화에 따른 만성질환(고혈압, 당뇨 등) 증가	약물 복용 중단 방지 및 지역 보건소 만성질환 관리 안내
유학생 (D-2, D-4)	기숙사 생활에 따른 결핵 감염 위험, 타향살이로 인한 심리적 고립감	보건소 결핵 검진 안내 및 청년 정신건강 상담 정보 제공
취약 이주민 (G-1, F-2-4)	체류 불안정으로 인한 트라우마, 건강보험 배제로 인한 필수 의료 사각지대	긴급의료비 지원사업 안내 및 심리적 지지 제공
미등록 이주민 (비자 없음)	단속 두려움 및 건강보험 미적용으로 인한 치료 지연	신분 확인 없는 필수 공중보건(결핵, 감염병 등) 서비스 우선 연계

3. 영유아·아동 건강권 실태

「2024 이주민 영유아 건강권 실태조사」 결과에 나타난 주요 통계는 다음과 같습니다.

주요 실태 지표

- **미등록 아동 증가:** 10세 미만 장기체류 미등록 아동은 2018년 1,321명에서 2023년 5,161명으로 약 3.9배 증가했습니다.
- **건강 인지 및 미충족 의료:** 주관적으로 건강하다고 인지하는 비율은 70.2%에 그쳤으며, 미충족 의료율은 19.3%로 나타났습니다.
- **의료기관 이용 형태:** 조기 치료 지연 등으로 인해 입원율은 36.8%, 응급실 이용률은 24.6%로 조사되었습니다.

- **예방접종 현황:** 필수 예방접종 완전접종률은 69.5%, 인플루엔자 접종률은 44.0% 수준입니다.
- **출산 지표:** 이주민 산모의 조산율은 12.1%로, 한국 평균(9.9%)보다 높게 나타났습니다.
- **의료기관 이용 장벽:** 병원 이용을 저해하는 주요 요인으로 의사소통의 어려움(52.0%), 비용 부담(45.0%), 시간 부족(25.1%), 단속에 대한 두려움(34.7%)이 꼽혔습니다.
- **비용 부담:** 미등록 이주민의 77.6%가 출산 및 신생아 치료비 지불에 심각한 어려움을 경험했습니다.

4. 의료보장제도에서 확인되는 실제 장벽

- **건강보험 의무가입 및 요건:** 2019년 이후 외국인 지역건강보험 가입이 의무화되었으나, 6개월 이상의 국내 체류 요건을 충족해야 합니다.
- **보험료 부담:** 전년도 전체 가입자 평균 보험료 이상을 부과받는 경우가 많아 경제적 취약계층에게 큰 부담이 됩니다.
- **세대원 범위 축소:** 내국인과 달리 세대원 인정 범위가 축소되어 가족 단위의 의료보장 적용이 까다롭습니다.
- **체납 시 불이익:** 보험료 체납 시 건강보험 급여가 즉시 제한되며, 비자 연장 등 체류 행정상 불이익이 발생합니다.
- **의료급여 및 지원 한계:** 의료급여 적용 대상이 극히 제한적이며, 미등록 이주민 대상 의료비 지원사업 역시 예산 한계와 지정 병원 부족으로 접근성이 낮습니다.

5. 교회·지역단체의 역할 (자료 기반 권고사항)

- **병원 동행 및 통역 연결:** 의사소통의 어려움(52.0%)을 해소하기 위해 병원 진료 시 동행하거나 지역 내 다국어 통역 자원을 연결합니다.
- **보건소 정보 전달:** 다국어 안내문 등을 활용하여 영유아 예방접종, 임산부 등록, 결핵 검진 등 보건소 공공 서비스 정보를 정확히 전달합니다.
- **조기 발견:** 위기 임산부, 예방접종 미완료 영유아, 고립된 유학생, 산재 위험에 노출된 노동자를 조기에 발견하여 보건소 및 관련 지원기관으로 연계합니다.
- **차별 완화 교육:** 지역사회 내 편견과 혐오가 이주민의 의료 접근성을 낮추는 요인이므로, 단체 구성원을 대상으로 이에 대한 이해 교육을 실시합니다.

6. 활동 시 유의사항

- **개인정보 및 체류상태 질문 지양:** 미등록 신분 노출에 대한 두려움(34.7%)이 병원 이용을 막는 주요 장벽이므로, 불필요하게 체류자격을 묻지 않아야 합니다.
- **두려움을 키우는 방식 피하기:** 단속기관을 연상케 하는 서류 요구 등 이주민의 심리적 불안을 가중시키는 행위를 삼가야 합니다.
- **제도 단정 금지:** 체류 자격이나 개별 상황에 따라 건강보험 적용 및 의료비 지원 여부가 다르므로, 공단이나 보건소 확인 없이 제도를 임의로 단정하여 안내하지 않습니다.

[작성 근거 자료]

본 안내문은 다음의 정책 연구 및 실태조사 자료에 확인된 내용을 바탕으로 작성되었습니다.

1. 「이주아동 건강권 관련 토론 정리_260115_192407.pdf」
2. 「영유아건강권실태조사_1218.pdf」
3. 「이주민과 의료보장제도(김사강 반영).pdf」
4. 「이주민 건강보호, 어떻게 제도화할 것인가(김창엽 교수).pdf」
5. 「지역보건의료기관 현황과 이주민 건강보장(반영).pptx」

[면책 문구]

본 문서는 관련 정책 연구 자료를 요약한 정보 제공용 목적입니다. 개별 이주민의 체류 자격에 따른 정확한 의료 혜택, 건강보험 가입 여부 및 행정 절차는 반드시 국민건강보험공단, 관할 보건소, 또는 출입국·외국인청(1345)을 통해 개별적으로 확인하시기 바랍니다.